RATUNEK DLA UTKNIĘTEGO PRZYPADKU™ · BONUS 2

Sytuacje Pilne Między Wizytami: Złamany Zamek, Kłujący Łuk, Złamany Aparat

25 sytuacji pilnych między wizytami: ocena, protokół i gotowy tekst do pacjenta.

Kompendium Ortodonty

Spis treści

Pierwsze 60 sekund w sytuacji pilnej

Indeks 25 sytuacji

1 · Zamek, rurka i pierścień

2 · Łuk i ligatura

3 · Ból i tkanka miękka

4 · Miniimplant

5 · Aparat

6 · Retencja i nakładka

7 · Uraz i połknięcie

Formularz rejestracji sytuacji pilnej

NA POCZĄTEK

Pierwsze 60 sekund w sytuacji pilnej

W każdej sytuacji pilnej należy zachować tę samą kolejność: bezpieczeństwo, przyczyna, rozwiązanie, rejestracja.

1. **Bezpieczeństwo:** Czy występuje problem z oddychaniem, krwawieniem, połykaniem lub uraz? Jeśli tak, to jest priorytet.
2. **Co się złamało, co kłuje?** Należy znaleźć część i upewnić się, że w ustach nie ma wolnych elementów.
3. **Czy pacjent jest bezpieczny?** Należy usunąć kłującą, drażniącą lub wolną część.
4. **Dlaczego?** Zwarcie, pokarm, klejenie, projekt aparatu. Należy odnotować.
5. **Decyzja:** naprawić teraz, zostawić do następnej kontroli lub skierować.
6. **Rejestracja:** Data, sytuacja, przyczyna, wykonany zabieg i informacja przekazana pacjentowi.

Sytuacje wymagające natychmiastowego skierowania

- Kaszel, duszność lub trudności w połykaniu z podejrzeniem połknięcia lub aspiracji
- Uraz zęba: wybicie, złamanie, uraz szczęki
- Rozprzestrzeniający się obrzęk, gorączka, wyciek
- Krwawienie, którego nie można zatrzymać

O tekstach do pacjenta

Pola **[Imię pacjenta]**, **[Nazwa kliniki]** i **[Data wizyty]** w tekstach należy wypełnić własnymi danymi. Teksty mają charakter informacyjny; należy je wysłać kanałem komunikacji używanym przez klinikę i w swoim stylu.

INDEKS

Indeks 25 sytuacji

Należy znaleźć sytuację, przejść do numeru.

NR	SYTUACJA	GRUPA
01	Odpadnięcie zamka na zębie przednim	Zamek, rurka i pierścień
02	Odpadnięcie zamka na zębie tylnym	Zamek, rurka i pierścień
03	Poluzowanie rurki trzonowej lub pierścienia	Zamek, rurka i pierścień
04	Dystalny koniec łuku kłuje w policzek	Łuk i ligatura
05	Wypadnięcie łuku z rurki	Łuk i ligatura
06	Złamany łuk	Łuk i ligatura
07	Kłujący koniec ligatury	Łuk i ligatura
08	Utrata ligatury elastycznej lub łańcuszka	Łuk i ligatura
09	Przemieszczenie sprężyny otwierającej	Łuk i ligatura
10	Ból i wrażliwość w pierwszych dniach	Ból i tkanka miękka
11	Rana na policzku lub wardze	Ból i tkanka miękka
12	Podrażnienie wokół miniimplantu	Miniimplant
13	Ruchomość lub wypadnięcie miniimplantu	Miniimplant
14	Poluzowanie śruby RME lub oddzielenie pierścienia	Aparat
15	Pęknięcie łuku podniebiennego	Aparat
16	Wrastanie guzika Nance'a w tkankę	Aparat
17	Złamanie ruchomego aparatu czynnościowego	Aparat
18	Pęknięcie połączenia stałego aparatu czynnościowego	Aparat
19	Podrażnienie skóry lub problem z połączeniem maski twarzowej	Aparat

NR	SYTUACJA	GRUPA
20	Pęknięcie stałej retencji lingwalnej	Retencja i nakładka
21	Nakładka przezroczysta lub Essix złamana lub zgubiona	Retencja i nakładka
22	Pęknięcie płytki Hawleya	Retencja i nakładka
23	Odpadnięcie zaczepu w leczeniu nakładkami	Retencja i nakładka
24	Uraz zęba u pacjenta z zamkami	Uraz i połknięcie
25	Podejrzenie połknięcia lub zgubienia części	Uraz i połknięcie

GRUPA 01

Zamek, rurka i pierścień

3 sytuacje

SYTUACJA 01 Odpadnięcie zamka na zębie przednim

Ocena: Czy zamek wisi na łuku, czy odpadł całkowicie? Czy powierzchnia zęba jest uszkodzona? Czy odpadnięcie wynika z kontaktu zwarciowego?

PROTOKÓŁ

1. Należy sprawdzić łuk i zamek; jeśli łuk nie kłuje, pacjent jest bezpieczny.
2. Należy odnotować przyczynę odpadnięcia: zwarcie, pokarm, powierzchnia klejenia.
3. Należy przykleić ponownie lub zaplanować na następną kontrolę.
4. Jeśli ten sam ząb odpada ponownie, należy sprawdzić kontakt zwarciowy.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], odpadnięcie zamka z zęba nie jest sytuacją pilną. Zamek może pozostać na łuku; jeśli nie kłuje, nie należy go dotykać. W [Nazwa kliniki] przykleimy go ponownie podczas kontroli w dniu [Data wizyty]. Należy unikać twardych i lepkich pokarmów.

Kiedy pilne: Jeśli towarzyszy temu złamanie zęba lub uraz, oceń tego samego dnia.

SYTUACJA 02 Odpadnięcie zamka na zębie tylnym

Ocena: Czy zamek przedtrzonowca obraca się na łuku, czy trze o policzek?

PROTOKÓŁ

1. Jeśli obracający się zamek trze o policzek, należy tymczasowo ustabilizować go lub usunąć.
2. Należy sprawdzić łuk; czy dystalny koniec kłuje?
3. Należy zaplanować ponowne przyklejenie.
4. Należy sprawdzić kontakt zwarciowy.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], zamek na zębie tylnym mógł się oddzielić. Jeśli trze o policzek, nałóż na niego wosk ortodontyczny. Naprawimy to na kontroli w dniu [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli występuje głęboka rana na policzku lub ryzyko połknięcia, umów wczesną wizytę.

SYTUACJA 03

Poluzowanie rurki trzonowej lub pierścienia

Ocena: Czy pierścień porusza się na zębie? Czy pod cementem gromadzi się pokarm?

PROTOKÓŁ

1. Należy zdjąć pierścień, oczyścić ząb i ocenić powierzchnię.
2. Należy zacementować ponownie lub dobrać nowy pierścień.
3. Jeśli aparat jest połączony (TPA, RME), należy sprawdzić jego integralność.
4. Należy odnotować poluzowanie w dzienniku.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], pierścień na zębie tylnym mógł się poluzować. Oczyść dokładnie obszar, aby nie gromadził się pokarm. Zaleca się wcześniejszą wizytę: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli pierścień całkowicie odpadł, a aparat jest wolny w ustach – tego samego dnia.

GRUPA 02

Łuk i ligatura

6 sytuacji

SYTUACJA 04 Dystalny koniec łuku kłuje w policzek

Ocena: Jak długi jest łuk poza rurką? Czy wydłużył się wraz z ruchem zęba (w miarę zamykania przestrzeni)?

PROTOKÓŁ

1. Należy odciąć nadmiar łuku; stępić koniec lub wygiąć i zamknąć.
2. Należy upewnić się, że odcięta część nie została w ustach.
3. Należy sprawdzić ranę na policzku.
4. Jeśli przestrzeń się zamyka, należy odnotować, by sprawdzić ponownie na następnej kontroli.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], jeśli koniec łuku kłuje w policzek, należy nałożyć na niego wosk ortodontyczny. Nie należy odcinać łuku samodzielnie. W [Nazwa kliniki] naprawimy to w dniu [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli łuk wrósł w tkankę i występuje krwawienie – wczesna wizyta.

SYTUACJA 05 Wypadnięcie łuku z rurki

Ocena: Czy łuk wyszedł z rurki, czy wolny koniec kłuje w tkankę?

PROTOKÓŁ

1. Należy wprowadzić łuk ponownie do rurki.
2. Należy sprawdzić przyczynę wyjścia: czy łuk jest krótki, czy występuje nadmierna aktywacja?
3. W razie potrzeby wymień łuk.
4. Jeśli jest wolny koniec, należy go zamknąć.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], łuk mógł wyjść ze swojego slotu na zębie tylnym. Jeśli kłuje, należy użyć wosku i nie ciągnąć za łuk. Twoja wizyta: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli wolny łuk powoduje zranienie – wczesna wizyta.

SYTUACJA 06

Złamany łuk

Ocena: Gdzie łuk jest złamany? Czy złamana część jest ruchoma, czy istnieje ryzyko połknięcia?

PROTOKÓŁ

1. Należy usunąć złamane części.
2. Wymienić łuk.
3. Należy odnotować miejsce złamania; jeśli się powtarza – kontakt zwarciowy lub zmęczenie materiału.
4. Należy sprawdzić pozycję zęba zgodnie z planem.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], łuk mógł pęknąć. Jeśli części się ruszają, nie należy próbować ich wyjmować; należy użyć wosku i umówić się na wcześniejszą wizytę: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli część zaginęła i istnieje podejrzenie połknięcia, należy sprawdzić Sytuację 25.

SYTUACJA 07

Kłujący koniec ligatury

Ocena: Czy koniec ligatury jest skierowany w stronę wargi lub policzka?

PROTOKÓŁ

1. Należy skrócić koniec i zagiąć pod zamek.
2. Należy sprawdzić inne ligatury.
3. Należy sprawdzić ranę.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], jeśli cienki koniec drutu kłuje w wargę, nałóż na niego wosk. Naprawimy to na kontroli: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Zazwyczaj nie jest pilne.

SYTUACJA 08

Utrata ligatury elastycznej lub łańcuszka

Ocena: Na którym zębie brakuje ligatury? Czy łuk wyszedł ze slotu? Czy otworzyła się przestrzeń?

PROTOKÓŁ

1. Uzupełnić brakujące ligatury.
2. Przy utracie łańcuszka zmierz stan przestrzeni.
3. Jeśli utrata jest częsta, należy porozmawiać o nawykach żywieniowych.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], jedna z małych gumek na zębach mogła odpaść. Nie jest to sytuacja pilna. Wymienimy ją na kontroli w dniu [Data wizyty].

Kiedy pilne: Zazwyczaj nie jest pilne.

SYTUACJA 09

Przemieszczenie sprężyny otwierającej

Ocena: Czy sprężyna przesunęła się, czy uciska dziąsło lub policzek?

PROTOKÓŁ

1. Należy umieścić sprężynę na miejscu lub usunąć.
2. Należy sprawdzić cel otwierania miejsca; czy otwarte miejsce jest chronione?
3. Należy sprawdzić stopery sprężyny.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], sprężyna między zębami mogła się przesunąć. Jeśli powoduje dyskomfort, należy użyć wosku. Twoja wizyta: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Jeśli występuje wrastanie w dziąsło i krwawienie – wczesna wizyta.

GRUPA 03

Ból i tkanka miękka

2 sytuacje

SYTUACJA 10 Ból i wrażliwość w pierwszych dniach

Ocena: Czy to nowa aktywacja? Czy ból jest na jednym zębie, czy rozlany?

PROTOKÓŁ

1. Należy odróżnić oczekiwaną wrażliwość od tej nienormalnej.
2. W przypadku silnego bólu na jednym zębie należy sprawdzić wczesny kontakt i stan miazgi.
3. Należy poinstruować pacjenta o miękkiej diecie i higienie jamy ustnej.
4. Leki przeciwbólowe według decyzji lekarza; dawkowanie nie jest podane w tym materiale.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], w pierwszych dniach po aktywacji można spodziewać się wrażliwości zębów. Należy wybierać miękkie pokarmy. Jeśli ból nie zmniejsza się po kilku dniach lub nasila się na jednym zębie, należy umówić się na wcześniejszą wizytę.

Kiedy pilne: Jeśli występuje obrzęk, gorączka lub nasilający się ból na jednym zębie – oceń tego samego dnia.

SYTUACJA 11 Rana na policzku lub wardze

Ocena: Rana znajduje się naprzeciw którego aparatu? Czy jest tam ostra część?

PROTOKÓŁ

1. Należy znaleźć przyczynę i usunąć ją (ostry koniec, haczyk, skrzydełko zamka).
2. Pokaż pacjentowi użycie wosku.
3. Należy monitorować ranę.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny [Imię pacjenta], rana w ustach może wynikać z tarcia aparatu. Nałóż wosk na drażniące miejsce. Jeśli rana nie wygoi się w ciągu kilku dni, umów się na wcześniejszą kontrolę.

Kiedy pilne: Jeśli rana nie goi się lub powiększa – ocena odpowiedniego specjalisty.

GRUPA 04

Miniimplant

2 sytuacje

SYTUACJA 12 Podrażnienie wokół miniimplantu

Ocena: Czy wokół występuje zaczerwienienie, obrzęk lub wyciek? Czy wykonywane jest czyszczenie?

PROTOKÓŁ

1. Oczyść obszar i oceń tkankę.
2. Należy odnowić instrukcję higieny.
3. Jeśli jest pod obciążeniem, należy sprawdzić stabilność śruby.
4. Należy odnotować sytuację.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], proszę ostrożnie czyścić tkankę wokół śruby miękką szczoteczką. Jeśli obrzęk lub wysięk się nasili, proszę przyspieszyć wizytę.

Kiedy zgłosić się pilnie: W przypadku rozprzestrzeniającego się obrzęku, gorączki lub wysięku – ocena tego samego dnia i w razie potrzeby skierowanie.

SYTUACJA 13 Ruchomość lub wypadnięcie miniimplantu

Ocena: Czy śruba jest ruchoma lub wypadła? Czy znaleziono wypadniętą śrubę?

PROTOKÓŁ

1. Nie należy obciążać ruchomej śruby.
2. Jeśli wypadła, sprawdzić okolicę; upewnić się, że śruba się nie zgubiła.
3. Zabezpieczyć mechanikę bez śruby.
4. Zaplanować decyzję o ponownym umieszczeniu i nową lokalizację.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], mała śruba w jamie ustnej mogła wypaść lub się poluzować. Jeśli została znaleziona, proszę ją zachować i przynieść na wizytę kontrolną. Proszę przyspieszyć wizytę: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: Jeśli śruba zaginęła i istnieje podejrzenie połknięcia, patrz Sytuacja 25.

GRUPA 05

Aparat

6 sytuacji

SYTUACJA 14 Poluzowanie śruby RME lub oddzielenie pierścienia

Ocena: Czy aparat się rusza? Czy śruba się obraca? Czy jest zapis aktywacji?

PROTOKÓŁ

1. Sprawdzić aparat i pierścienie.
2. W razie potrzeby zdjąć aparat i ponownie go zacementować.
3. Wstrzymać aktywację i zaktualizować zapis.
4. Zmierzyć stan ekspansji.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], aparat do ekspansji podniebienia mógł się poluzować. Proszę wstrzymać rozkręcanie śruby. Proszę przyspieszyć wizytę: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: Jeśli aparat stał się luźny w jamie ustnej – tego samego dnia.

SYTUACJA 15 Pęknięcie łuku podniebiennego

Ocena: Gdzie jest punkt pęknięcia: lut czy pierścień? Czy łuk jest luźny?

PROTOKÓŁ

1. Usunąć luźny element.
2. Ocenić potrzebę zakotwienia; zaplanować rozwiązanie tymczasowe.
3. Wymienić aparat.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], łuk podniebienny mógł się odłączyć. Jeśli element jest ruchomy, należy go ostrożnie usunąć lub zabezpieczyć woskiem i przyspieszyć wizytę.

Kiedy zgłosić się pilnie: Jeśli element jest luźny i istnieje ryzyko połknięcia – tego samego dnia.

SYTUACJA 16

Wrastanie guzika Nance'a w tkankę

Ocena: Czy na błonie śluzowej podniebienia widoczny jest odcisk, owrzodzenie lub stan zapalny?

PROTOKÓŁ

1. Odsunąć aparat od tkanki lub go usunąć.
2. Należy monitorować gojenie tkanki.
3. Należy odnowić instrukcję higieny.
4. Zaplanować tymczasowe rozwiązanie dla zakotwienia.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], aparat na podniebieniu może uciskać tkankę. Proszę dbać o czystość okolicy, ocenimy to na wizycie: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: W przypadku niegojącego się owrzodzenia – skonsultować ze specjalistą.

SYTUACJA 17

Złamanie ruchomego aparatu czynnościowego

Ocena: Gdzie jest pęknięcie? Czy aparat nadal daje się założyć?

PROTOKÓŁ

1. Ocenić pęknięcie; podjąć decyzję o naprawie lub wymianie.
2. Jeśli aparatu nie można założyć, odnotować etap leczenia.
3. Poinstruować pacjenta, aby nie zakładał pękniętego aparatu.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli aparat pękł, proszę go nie zakładać i zachować części. Proszę przynieść je na wizytę: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: Zazwyczaj nie jest to sytuacja pilna; naprawa w krótkim czasie, aby nie przerywać leczenia.

SYTUACJA 18

Pęknięcie połączenia stałego aparatu czynnościowego

Ocena: Czy połączenie całkowicie puściło? Czy aparat jest luźny w jamie ustnej?

PROTOKÓŁ

1. Usunąć luźne elementy.
2. Należy wymienić połączenie.
3. Sprawdzić ruchomość żuchwy.
4. Odnotować powtarzające się uszkodzenia.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], połączenie aparatu stałego na zębach mogło się odłączyć. Proszę nie otwierać szeroko ust i przyspieszyć wizytę: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: Jeśli element jest luźny – tego samego dnia.

SYTUACJA 19

Podrażnienie skóry lub problem z połączeniem maski twarzowej

Ocena: Czy na skórze występuje zaczerwienienie lub rana? Czy haczyki w jamie ustnej są sprawne?

PROTOKÓŁ

1. Skorygować punkty ucisku.
2. Sprawdzić połączenia wewnątrzustne.
3. Ponownie omówić z pacjentem czas i sposób noszenia.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli w miejscach styku maski z twarzą występuje zaczerwienienie, skorygujemy to na wizycie. Jeśli powstanie rana, proszę przerwać noszenie maski i przyspieszyć wizytę.

Kiedy zgłosić się pilnie: W przypadku rany na skórze lub objawów infekcji – skonsultować z lekarzem.

GRUPA 06

Retencja i nakładka

4 sytuacje

SYTUACJA 20 Pęknięcie stałej retencji lingwalnej

Ocena: Na którym zębie wystąpiło odklejenie? Czy zęby się przemieściły?

PROTOKÓŁ

1. Odnotować odklejenie i pozycję zębów.
2. Naprawić lub wymienić.
3. Jeśli wystąpił nawrót, zmierzyć jego wielkość.
4. Przejrzeć plan retencji (Przewodnik 2).

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeden z końców cienkiego drucika za zębami mógł się odłączyć. Zaleca się przyspieszenie wizyty, aby zęby się nie przesunęły: [Data wizyty]. Jeśli posiada Pan/Pani nakładkę przezroczystą, proszę ją nadal nosić.

Kiedy zgłosić się pilnie: W przypadku kłucia i rany – wczesna wizyta.

SYTUACJA 21 Nakładka przezroczysta lub Essix złamana lub zgubiona

Ocena: Od jak dawna nakładka nie jest używana? Czy zęby się przesunęły?

PROTOKÓŁ

1. Zaplanować wycisk lub skan pod nową nakładkę.
2. Sprawdzić pozycję zębów.
3. Odnotować czas utraty.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli zgubił(a) Pan/Pani nakładkę lub uległa ona pęknięciu, w krótkim czasie potrzebna jest nowa, aby zęby się nie przesunęły. Proszę przyspieszyć wizytę: [Data wizyty].

Kiedy zgłosić się pilnie: Zazwyczaj nie jest to sytuacja pilna; zwłoka może prowadzić do nawrotu.

SYTUACJA 22

Pęknięcie płytki Hawleya

Ocena: Czy pęknięcie jest w akrylu, czy w drucie? Czy nakładka nadal pasuje?

PROTOKÓŁ

1. Podjąć decyzję o naprawie lub wymianie.
2. Należy sprawdzić dopasowanie.
3. Upewnić się, że pęknięty element nie wbija się w tkankę.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli nakładka pękła, proszę jej nie zakładać i zachować części. Proszę przynieść je na wizytę: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Zazwyczaj nie jest pilne.

SYTUACJA 23

Odpadnięcie zaczepu w leczeniu nakładkami

Ocena: Który zaczep? Czy nakładka pasuje?

PROTOKÓŁ

1. Odtworzyć zaczep za pomocą szablonu.
2. Należy sprawdzić dopasowanie.
3. Pokazać pacjentowi technikę zdejmowania nakładki.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeden z małych wypustków na zębie mógł odpaść. Proszę nadal nosić nakładkę; odtworzymy go na wizycie: [Data wizyty].

Kiedy pilne: Zazwyczaj nie jest pilne.

GRUPA 07

Uraz i połknięcie

2 sytuacje

SYTUACJA 24 Uraz zęba u pacjenta z zamkami

Ocena: Które zęby zostały dotknięte? Czy występuje ruchomość, złamanie, przemieszczenie?

PROTOKÓŁ

1. Ocenić zęby, kość i tkanki miękkie.
2. Wykonać zdjęcie rentgenowskie.
3. Usunąć aktywne siły z zęba po urazie.
4. Udokumentować żywotność i zaplanować obserwację (Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza).
5. W razie potrzeby skierować do odpowiedniego specjalisty.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli doszło do urazu zębów, konieczna jest ocena tego samego dnia. Jeśli ząb lub jego część wypadła, proszę ją zachować i niezwłocznie zgłosić się do gabinetu.

Kiedy zgłosić się pilnie: W przypadku wybicia zęba, złamania lub urazu szczęki – tego samego dnia; w razie potrzeby pomoc doraźna.

SYTUACJA 25

Podejrzenie połknięcia lub zgubienia części

Ocena: Który element zaginął? Czy u pacjenta występuje kaszel, duszność, trudności w przełykaniu?

PROTOKÓŁ

1. Ostrożnie sprawdzić jamę ustną.
2. Jeśli występują objawy oddechowe, niezwłocznie skierować pacjenta na pilną ocenę medyczną.
3. Jeśli brak objawów, odnotować sytuację i zaplanować ocenę medyczną zgodnie z decyzją lekarza.
4. Ustalić przyczynę wypadnięcia elementu.

DO PRZEKAZANIA PACJENTOWI

Szanowny Panie / Szanowna Pani [Imię pacjenta], jeśli podejrzewa Pan/Pani połknięcie elementu aparatu i występuje kaszel, duszność lub trudności w przełykaniu, proszę niezwłocznie udać się na najbliższy SOR. Jeśli brak objawów, proszę przyspieszyć wizytę; wspólnie zdecydujemy o dalszym postępowaniu.

Kiedy zgłosić się pilnie: Objawy oddechowe są zawsze sytuacją pilną.

FORMULARZ

Formularz rejestracji sytuacji pilnej

Formularz dla każdej sytuacji pilnej. Należy powielać do użytku.

Rejestracja sytuacji pilnej 1

Pacjent

Data

Nr i nazwa sytuacji

Co się stało (opis pacjenta)

Ustalenia

Możliwa przyczyna

Wykonane czynności

Informacja przekazana pacjentowi

Czy sytuacja się powtarza?

Następna kontrola

Rejestracja sytuacji pilnej 2

Pacjent

Data

Nr i nazwa sytuacji

Co się stało (opis pacjenta)

Ustalenia

Możliwa przyczyna

Wykonane czynności

Informacja przekazana pacjentowi

Czy sytuacja się powtarza?

Następna kontrola

Materiał ma charakter edukacyjny. Nie zastępuje badania klinicznego, decyzji lekarza ani opinii specjalisty.

Następny krok

Jeśli sytuacja pilna się powtarza, wypełnić analizę przyczyn źródłowych w **Dzienniku Przypadku**. Jeśli widoczna jest przyczyna mechaniczna, otworzyć **Atlas Rozwiązywania Problemów Mechanicznych**, a w przypadku urazu – **Przewodnik 4 · Urazy i Ankyloza**.